

MyLoo

pour patient-advocates et créateurs gut-health - et ce que dit la recherche

"Photo dedans, IA classifie, PDF clinique dehors. Privacy-first. Gagne sur la valeur que tu crées déjà."

Tu as répondu, merci. Voici le compagnon long de la mail. Il fait le point sur ce que dit la recherche sur UGC vs faceless et montre quelle voie correspond à chaque type de créateur.

Sommaire : 1. L'app + business · 2. UGC vs faceless · 3. Tableau types de créateurs · 4. Stratégie UGC · 5. Stratégie faceless · 6. Fit audience · 7. Cadence · 8. Maths · 9. Tracking · 10. Onboarding · 11. Dashboard · 12. Assets · 13. FAQ · 14. Une dernière chose

1. L'app + business en 60 secondes

MyLoo est un tracker digestion/selles pour iOS (Android en pause - Google Health Policy 2026). Photo de l'échantillon, Claude Vision IA classifie sur la Bristol Stool Scale 1-7. Privacy-first : photos NON stockées, seul le résultat structuré en timeline. Tags symptômes, PDF 30 jours pour rendez-vous GI.

Pourquoi ça vend

Le tracking en Word-doc c'est la réalité pour 80% des patients IBS. MyLoo résout ça : au rendez-vous GI tu montres un PDF avec données réelles au lieu de parler rétrospectivement 4 semaines.

Free vs Premium

- Gratuit : saisie Bristol manuelle + tags symptômes, timeline, export PDF manuel.
- Premium (4,99 USD/m ou 29,99 USD/y) : classification IA photo, parsing email-inbound, export étendu.
- Premium gratuit à vie pour affiliés onboarded.

2. UGC vs faceless - ce que dit la recherche

Le contenu face-à-la-caméra (UGC) convertit en moyenne mieux que le contenu faceless. Le faceless fonctionne quand même - juste différemment.

Deux résultats de la recherche peer-reviewed sur l'influencer marketing valent la peine d'être connus. D'abord, Sokolova et Kefi (2020) ont montré que l'interaction parasociale - le sentiment qu'un créateur est un ami que tu connais via ton téléphone - est un puissant moteur d'intention d'achat sur Instagram et YouTube. La confiance parasociale se construit plus vite quand le public voit un visage, entend une voix, et regarde une personne faire des choix. Ensuite, Lou et Yuan (2019) ont trouvé que la crédibilité perçue du créateur (fiabilité, expertise, attractivité) augmente directement la confiance du consommateur dans le contenu sponsorisé ; la visibilité du créateur est l'un des signaux de crédibilité les plus forts. Les données sectorielles des benchmarks annuels de l'Influencer Marketing Hub placent constamment les Reels et TikToks face-à-la-caméra à un engagement plus élevé que les pures screen-recordings, même si l'écart varie beaucoup selon la niche.

La nuance

Le faceless a de vrais atouts. Quand la démonstration est auto-explicative - un outil qui fait la chose, un B-roll satisfaisant, un screen-recording qui comprime une tâche de 20 minutes en 30 secondes - le produit remplace la personnalité. Le faceless scale aussi : coût de production plus bas par post, pas de nerfs devant la caméra, plus facile à externaliser. Le coût c'est la confiance parasociale, ce qui signifie une conversion plus basse par vue mais souvent une reach plus large.

Quand chaque voie marche

L'UGC fonctionne quand le face-à-la-caméra est ton atout de crédibilité (toi, ton métier, ta réalité quotidienne), quand la confiance compte plus que la reach, et quand tu dirais naturellement "Je l'utilise personnellement". Le faceless fonctionne quand la démonstration se tient toute seule (le produit à l'écran fait le travail), quand tu veux scaler la production, quand être devant la caméra n'est pas une option, ou quand tu postes sous une brand-persona plutôt que personnelle.

Sources

- Sokolova, K., & Kefi, H. (2020). Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 53, 101742.
- Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. *Journal of Interactive Advertising*, 19(1), 58-73.
- Influencer Marketing Hub. (2024). *The State of Influencer Marketing Benchmark Report 2024*.
- HypeAuditor. (2024). *State of Influencer Marketing Report*.

3. Types de créateurs - quelle voie te correspond

Pour MyLoo spécifiquement, les créateurs avec expérience vécue convertissent dramatiquement mieux que les comptes esthétiques - les audiences santé voient à travers la performance.

Type de créateur	Voie principale	Meilleurs hooks	Conversion réaliste
IBS/IBD day-in-the-life	UGC fort	Moment Word-doc ; "comment je prépare ma visite GI" ; reveal PDF 30 jours ; "enfin un outil de confiance"	3-5%, confiance + share-rate très haut
Low-FODMAP/intolérances	UGC + Faceless mix	Timeline corrélation aliment-symptôme ; "ce que j'ai mangé vs comment je me sentais" ; histoire découverte déclencheur	2-4% en niches élimination
Patient-advocate/éducateur IBS-IBD	UGC	Educational avec données perso ; "pourquoi la Bristol scale compte" ; "quoi apporter à ta visite GI"	2-4%, autorité très haute
Pro santé en capacité personnelle	UGC (avec disclosure)	"Ce que je voudrais que mes patients tracent" ; walkthrough clinical-grade ; "le PDF que je veux en rendez-vous"	2-4% mais respecte règles pro
Anonyme gut-health TikTok	Faceless	Éducation Bristol scale silencieuse ; tutorial tracking voiceless ; démo privacy-first photo	1-2% par vue, haute fréquence post
Post-chirurgie/chronique	UGC primaire	Timeline recovery ; "ce qui m'a aidé à me sentir entendu en rendez-vous" ; valeur tracking structuré	2-3% en communautés chroniques

4. Stratégie UGC (toi à la caméra)

À qui ça convient

Toi avec la condition. Patient IBS partageant day-in-the-life. Post-chirurgie traçant recovery. Patient-advocate avec crédibilité. Health-condition content voit à travers la performance - ton expérience vécue c'est tout le modèle de crédibilité.

Hooks qui fonctionnent

- "Ça a remplacé mon Word-doc" - talking head avec vrai Word-doc 4 semaines, puis timeline MyLoo.
- "Comment je prépare ma visite GI maintenant" - calme 60s, finissant par export PDF.
- "An un d'IBS - ce que j'aurais voulu tracer dès le jour un" - rétrospective.
- "Mon gastro a vraiment travaillé avec les données cette fois" - débrief post-visite.
- "L'IA a classifié ce que je n'arrivais pas à regarder" - angle privacy.
- "Ce qui a changé en 30 jours de tracking" - pattern-discovery.
- "Pourquoi la Bristol scale compte et pourquoi personne ne te le dit" - educational.

Templates de format

- Talking head 60s.
- Day-in-the-life 90s.
- Educational vlog 75s.
- Payoff émotionnel : débrief post-visite.
- Rétrospective : "an un avec IBS".
- Comparaison : Word-doc vs MyLoo.

À faire / À éviter

- Do : poste seulement si tu as vraiment la condition ou travailles dans le secteur.
- Do : nomme ta condition/contexte spécifiquement.
- Do : discute la privacy honnêtement.
- Don't : donner conseils médicaux.
- Don't : médicaliser le marketing.
- Don't : overseller l'IA.

5. Stratégie faceless (screen-rec, voix off, B-roll)

À qui ça convient

Éducateur patient anonyme. Pro santé en capacité personnelle. Compte chronique voix-off seulement.

Hooks qui fonctionnent

- Carrousel infographie Bristol scale silencieux.
- 30s screen-rec classification IA avec voix off.
- "Privacy-first photo - ce que 'pas stockées' veut vraiment dire" - carrousel.
- "Quoi apporter à ta première visite GI" - tutorial carrousel.
- "5 apps qui aident vraiment avec l'IBS" - listicle, MyLoo #1-2.
- Time-lapse symptom-tracking - main anonyme.
- Comparaison Word-doc vs MyLoo split-screen.

Templates de format

- Carrousel educational : 6 slides, esthétique clinique calme.
- Screen-rec démo 20-30s.
- Voix off narrative 45s.
- Listicle.
- Tutorial : setup étape-par-étape.
- Comparaison silencieuse.

À faire / À éviter

- Do : ton clinique-calme - l'audience de MyLoo déteste l'esthétique wellness.
- Do : caption chaque étape.
- Do : cite sources crédibles (NHS, Mayo Clinic, Rome IV) en enseignant.
- Do : lien en caption + bio.
- Don't : couleurs wellness-esthétique vives.
- Don't : prétendre être patient si tu ne l'es pas.

6. Fit audience

Fonctionne bien pour

- Créateurs IBS/IBD day-in-the-life.
- Channels nourriture low-FODMAP.
- Patient-advocate IBS/IBD pages.
- Journaux post-chirurgie/chroniques.
- Anonymes gut-health TikTok (privacy comme brand).
- Pros santé en capacité personnelle.

Fonctionne mal pour

- Esthétique wellness-influenceur.
- Angle diagnostique / 'IA te dit ce que tu as'.
- Comptes lifestyle généraux sans connexion gut-health réelle.

7. Cadence

Gut-health : dimanche soir + mercredi soir. IBS day-in-the-life : mardi-jeudi matin. Patient-advocate : tard soir 21-23h. 1 reel par semaine. Stories avec lien après rendez-vous GI guident conversion.

8. Maths de conversion

50% rev-share, 24 mois. Premium 4,99 USD/m ou 29,99 USD/y. IBS day-in-the-life micro (40k abonnés) : 20 000 vues x 2,5% CTR = 500 clics, 40% install = 200 installs, 6% Premium = 12 abonnés, ~180 USD par reel. Patient-advocate mid-tier (100k) : 50 000 vues x 2% CTR = 1 000 clics, 35% install = 350 installs, 5% Premium = 17 abonnés, ~255 USD. Anonyme gut-health macro (300k TT) : 150 000 vues x 1% CTR = 1 500 clics, 30% install = 450 installs, 4% Premium = 18 abonnés, ~270 USD. Utilisateurs chroniques gardent les subs plus longtemps que la moyenne.

9. Tracking (résumé)

Ton lien [myloo.org/i/\[tonpseudo\]](https://myloo.org/i/[tonpseudo]) marche sur toutes les plateformes. Android utilise le Google install-referrer (déterministe). iOS warm utilise Universal Link (déterministe). iOS cold (~99 % du trafic créateur) utilise notre deferred-deeplink signé via presse-papiers DIY, vérifié en live, sans Branch.io. RevenueCat se déclenche à l'achat Premium et crédite 50 % du revenu net à ton handle pendant 24 mois à partir du premier mois payé de chaque utilisateur. 30 jours de retenue remboursement avant que le paiement devienne réclamable. Le walkthrough complet est dans le PDF du Brief Étendu.

10. Onboarding (5 minutes)

- Clique sur le lien personnel dans la Mail 2 (valide 7 jours).
- Tu atterris sur [myloo.org/affiliate/\[ton-token\]](https://myloo.org/affiliate/[ton-token]).
- Tu remplis : handle, détails Wise pour les paiements, pays (pour les documents fiscaux), adresse de facturation.
- Tu reçois ton lien de tracking personnel par mail + déverrouillage du tableau de bord.
- Premium gratuit à vie activé. Aucune obligation de publication, aucune expiration.

11. Tableau de bord

- Live sur getklar.org/dashboard (login magic-link).
- Par jour / semaine / mois : clics, installs (split Android / iOS warm / iOS cold), abonnés Premium actifs dans ton bucket.
- EUR réclamables + EUR payés + prochaine date de paiement.
- Pipeline retenue remboursement + funnel gains par app.

12. Assets de marque

Logo, captures app, slides educational Bristol-scale (revues médicalement), identité visuelle clinique-calme et captions prêts : getklar.org/i/myloo/brand-assets.

13. FAQ

Je suis pro santé, je peux poster ?

Oui, en capacité personnelle avec disclosure. Cadre comme 'outil que les patients peuvent utiliser', pas 'outil qui diagnostique'.

Et Android ?

Construit et testé mais pausé à l'étape Google Health Policy (compte corporate + D-U-N-S). Ton lien marche pour Android - page waitlist.

Je peux montrer de vraies photos ?

Non. Privacy-first signifie que les photos ne sont jamais stockées - c'est le déblocage de confiance. Utilise la vue résultat structuré.

Disclosure ?

Oui, rev-share = recommandation rémunérée. Plus : pros santé suivent règles de conduite locales.

Compensation fixe ?

Mid-tier \$150-500, macros \$500+. Rev-share reste par-dessus.

Et si je perds ma crédibilité de niche ?

Ne poste pas si MyLoo ne colle pas à ton expérience vécue ou contexte professionnel.

14. Une dernière chose

Honnêtement : MyLoo colle avec des créateurs ayant une vraie expérience gut-health ou contexte professionnel. Si tu n'as pas d'IBS, ne travailles pas en healthcare, et ton audience n'est pas dans une niche santé, ça ne colle pas et on préférerait que tu ne postes pas. Les audiences patientes voient à travers la performance. Réponds à la Mail 2 si tu veux en parler.

Pour les posts avec lien affilié : #ad / #sponsorisé / Paid Partnership (FTC, droit européen).